3.2.6.1. 자살 또는 자해 위험 환자 관리

제 정 일	2018.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	정신건강의학과, 소아정신과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	JCI Standard 7th Edition: COP.3.5

제1조 (목적)

1. 자살 또는 자해 위험성이 있는 환자에게 안전하고 일관된 진료를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 자살: 당사자가 자유의사에 의하여 스스로의 목숨을 끊는 행위
2. 자해: 자신의 신체에 의도적인 고통 혹은 상해를 가하는 행위

제3조 (절차)

1. 위험 환자 관리
   1) 정서 상태 평가: 의사는 환자의 정서 상태를 확인하고 협진 필요 여부를 평가하여 세브란스병원 내규 [3.1.2.1. 협의진료체계]에 따라 협진을 의뢰하며, 필요 시 보호병동으로 전동을 고려한다.
   2) 스크리닝 및 관리
      (1) 1일 1회 이상 환자의 정서상태를 확인한다.
      (2) 환자 및 대리인에게 교육을 제공한다.
         ① 환자 곁에 보호자가 항상 함께 하도록 한다.
         ② 필요 시 의료진의 도움을 요청하도록 한다.
         ③ 위해도구로 사용될 수 있는 물건을 교육하고 관리하도록 교육한다.

2. 정신건강의학과 입원 시 관리
   1) 초기평가: 의사는 입원하는 모든 환자에게 정신상태 검사를 통하여 환자의 자살 위험성을 자세히 조사하고, [부록2. 자살의 위험성 평가(SSS)]를 이용하여 자살 위험 정도를 평가한다. 필요 시 [부록3. 자해의 위험성 평가(SDSHS)]를 이용하여 자해 위험 정도를 평가한다.
   2) 재평가: 다음에 해당할 경우 재평가를 시행하고 그 외 정기적인 RISK ASSESSMENT MEETING을 통하여 환자의 자살 위험도를 재평가한다.
      (1) 정신과적 증상의 급격한 변화 (예: 우울감의 급격한 악화 혹은 호전)
      (2) 심각한 내외과적 문제의 발생 (예: 생명의 위협, 심한 통증, 실행기능의 손상)
      (3) 급격한 환경의 변화: 담당의 변경, 주변 환경의 변경 (예: 이혼, 금전적 손실)
      (4) 퇴원 시

3) 위험군 분류 및 관리

(1) 고위험군

① 자살 고위험군

a. 임상적으로 자살의 위험이 높다고 판단될 때(예; 자살에 대한 계획이 있으며 실천할 가능성이 높은 경우

b. [부록2. 자살의 위험성 평가(SSS)] 점수 14~20점

② 자해 고위험군

a. 임상적으로 자해의 위험이 높다고 판단될 때(예: 현재 자해에 대한 욕구가 크고 이전의 자해 강도가 심각하며 자해 행동의 종류 및 자해 빈도가 높아 자해 시 의학적 처치가 필요한 상해가 예상되는 경우)

b. [부록3. 자해의 위험성 평가(SDSHS)] 점수 13~18점

③ 자살, 자해 고위험군 환자 관리

a. Suicidal precaution, Self-Harm precaution 처방

b. [부록4. 자살예방 약속(No Harm Contract)] 및 [부록5. 의도적 자해 예방을 위한 약속(No Harm Contract)] 작성

c. 보호자 24시간 keep

d. 자살, 자해의 충동 조절이 매우 어려운 때에는 일시적으로 모니터가 달린 안정실 조치

e. 자유로운 산책 및 외출 금지: 환자가 병동 밖을 혼자 나가지 못하도록 제한하고 치료적인 목적 혹은 불가피한 사유로 산책이나 외출이 필요한 경우에는 반드시 보호자 동반 하에 나가도록 해야 하며, 1 시간 이내로 제한한다.

f. 위해도구 관리: 자살, 자해 도구로 이용될 물건이 없는지 매일 사물 검사를 시행, 같은 병실의 환자에게도 물품 관리에 대해 협조를 요청

g. 하루 3회 자살사고에 대한 의사의 확인과 개입, 1시간에 1번씩 간호사 라운딩하여 환자의 위치와 안전한 환경을 확인

h. 자살 고위험군은 매일 [부록2. 자살의 위험성 평가(SSS)]를 통해 자살 위험성을 재평가하고 기록으로 남기고, 자해 고위험군은 매일 [부록3. 자해의 위험성 평가(SDSHS)]를 통해 자해 위험성을 재평가하고 기록으로 남김

(2) 중등도 위험군

① 자살 중등도 위험군

a. 임상적으로 자살의 위험이 있긴 하나 행동으로 옮길 위험은 적다고 판단될 때(예: 자살 실천가능성이 높지는 않지만 자살에 대한 생각이 있는 경우)

b. [부록2. 자살의 위험성 평가(SSS)] 점수 6~13점

② 자해 중등도 위험군

a. 임상적으로 자해의 위험이 중등도로 판단될 때(예; 현재 자해 욕구가 분명하고 이전의 자해 강도, 자해 행동, 자해 빈도가 중등도에 해당하며 자해 시 심각한 상해는 예상되지 않는 경우)

b. [부록3. 자해의 위험성 평가(SDSHS)] 점수 7~12점

③ 자살, 자해 중등도 위험군 환자 관리

a. Suicidal precaution, Self-Harm precaution 처방

b. [부록4. 자살예방 약속(No Harm Contract)] 및 [부록5. 의도적 자해 예방을 위한 약속(No Harm Contract)] 작성
c. 필요시 보호자 24시간 keep
d. 자유로운 산책 및 외출 금지: 환자가 병동 밖을 혼자 나가지 못하도록 제한하고 치료적인 목적 혹은 불가피한 사유로 산책이나 외출이 필요한 경우에는 반드시 보호자 동반 하에 나가도록 해야 하며 2 시간 이내로 제한
e. 하루 2회 자살, 자해사고에 대한 의사의 확인과 개입, 2시간에 1번씩 간호사 라운딩하여 환자의 위치와 안전한 환경을 확인
f. 자살 중등도 위험군은 이틀에 한 번씩 [부록2. 자살의 위험성 평가(SSS)]를 통해 자살 위험성을 재평가하고 기록으로 남기고, 자해 중등도 위험군은 이틀에 한 번씩 [부록3. 자해의 위험성 평가(SDSHS)]를 통해 자해 위험성을 재평가하고 기록으로 남김
g. 자살, 자해 도구로 이용될 물건이 없는지 이틀에 한 번 사물 검사를 시행

(3) 저위험군
① 자살 저위험군
a. 임상적으로 자살의 위험이 낮다고 판단되는 경우
b. [부록2. 자살의 위험성 평가(SSS)] 점수 0~5점
② 자해 저위험군
a. 임상적으로 자해의 위험이 낮다고 판단되는 경우
b. [부록3. 자해의 위험성 평가(SDSHS)] 점수가 0~6점
③ 자살, 자해 저위험군 환자 관리: 주 2회 주기적인 재평가

(4) Suicidal, Self-Harm precaution
① 자살 위험군에 해당되는 환자 발생 시 의사는 'Suicide precaution' 처방을 낸다.
② 자해 위험군에 해당되는 환자 발생 시 의사는 'Self-Harm precaution' 처방을 낸다.
③ 필요하다고 판단되는 경우, 환자를 간호사실에서 가까운 병실로 옮긴다.
④ 병동회의를 포함한 치료자 간 커뮤니케이션(RISK ASSESSMENT MEETING)을 통해 자살, 자해 위험 환자의 상태를 평가 및 재평가하여 위험도를 파악하고 그 위험성에 대해서 치료자 전원이 알고 있도록 한다. (정기적인 팀미팅)
⑤ 근무 교대 시 반드시 자살, 자해 위험 환자의 상태를 확인하고 자살, 자해 위험도와 관련된 변화가 있을 경우, 즉시 주치의(담당교수) 혹은 담당의사(전공의)와 책임 간호사에게 보고한다.

(5) Psychiatric management
① 치료적 관계의 확립
② 안전성을 확보
③ 치료 계획의 수립
④ 재평가

3. 자살, 자해 예방 및 관리를 위해 환자안전사건을 분석하고 개선활동을 진행한다.

4. 의료진은 자살, 자해 위험이 있는 환자 관리에 대한 교육을 받는다.

제4조 (부록)

1. 자살, 자해 위험도에 따른 알고리즘
2. 자살의 위험성 평가(SSS, Severance Suicide Scale)
3. 자해의 위험성 평가(SDSHS, Severance Deliberate Self Harm Scale)
4. 자살예방 약속(No Harm Contract)
5. 의도적 자해 예방을 위한 약속(No Harm Contract)

제5조 (참고)

1. Textbook of Psychiatry, 9th edition, Benjamin James Sadockl, Lippincott, 2009
2. Synopsis of Psychiatry, ninth edition, Benjamin James Sadock, Lippincott Williams & Wilkins, 2003

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2018년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)